

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

2^{da.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 858

17 de noviembre de 2025

Presentado por señor Ríos Santiago

Referido a la Comisión de Salud

LEY

Para enmendar el Artículo 1.02, añadir nuevos incisos (k-1), (u-1), (u-2), (aa-1), (dd-1), (dd-2) y (nn-1) al Artículo 1.03, añadir un nuevo inciso (f) al Artículo 5.04, añadir un nuevo Artículo 5.11-A, enmendar el Artículo 5.16 y añadir un nuevo Artículo 5.18 de la Ley 247-2004, según enmendada, conocida como “Ley de Farmacia de Puerto Rico”, a los fines de establecer un marco regulatorio para los medicamentos compuestos de alto riesgo y las farmacias no residentes que permita la responsable protección salubrista de los pacientes localizados en Puerto Rico; sin imponer requisitos duplicativos a farmacias físicamente localizadas en la jurisdicción de Puerto Rico, debidamente licenciadas bajo la Ley 247-2004; establecer la “Ley para la Supervisión sobre Medicamentos Compuestos de Alto Riesgo”; requerir la publicación de informes bianuales por parte de la la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARPS) junto con la Oficina de Planificación y Desarrollo Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS), y la Junta Examinadora de Farmacia sobre la supervisión de las prácticas de preparación de medicamentos compuestos; garantizar una mayor visibilidad sobre las acciones regulatorias para proteger a los pacientes de medicamentos preparados ilegalmente; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La preparación ilegal de medicamentos compuestos representa un desafío creciente y de gran magnitud en Puerto Rico, que pone en riesgo la seguridad de los pacientes y la integridad del sistema de salud. Los ciudadanos merecen medicamentos

en los que puedan confiar, que sean seguros, efectivos y elaborados conforme a los más altos estándares de calidad establecidos por las regulaciones estatales y federales. Sin embargo, en los últimos años, se ha observado un aumento alarmante en la distribución de medicamentos compuestos sin la supervisión adecuada, lo que constituye una amenaza significativa para la salud pública. Este problema es particularmente pronunciado en el caso de los medicamentos GLP-1 utilizados para el tratamiento de la diabetes y la obesidad, aunque se extiende a otras clases de medicamentos, afectando a diversos sectores de la población.

La preparación de medicamentos compuestos, cuando se realiza conforme a las normativas, es una práctica esencial que permite adaptar tratamientos a las necesidades específicas de los pacientes. No obstante, la proliferación de actividades de preparación ilegal, especialmente en entornos no regulados como spas médicos y clínicas de bienestar, ha ~~generado~~ evidenciado un vacío regulatorio que trasciende la mera supervisión del establecimiento físico o del profesional que realiza el procedimiento. El problema salubrista no radica únicamente en la práctica estética, sino en el manejo y administración de medicamentos compuestos cuya naturaleza requiere controles y supervisión especializada. Cuando estos productos son preparados sin receta individual previa, adquiridos como ingredientes farmacéuticos activos sin adecuada trazabilidad, o prescritos mediante evaluaciones insuficientes, se desdibuja la línea entre la composición farmacéutica legítima y la manufactura no regulada. Ello coloca al paciente en una posición de vulnerabilidad y dificulta la intervención temprana del Estado ante eventos adversos o prácticas negligentes. ~~en la supervisión de los entes reguladores.~~ Estos establecimientos, que a menudo operan sin la fiscalización de la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública ~~Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud~~ (en adelante, SARPSS~~SARAES~~) y la Junta Examinadora de Farmacia en materia de medicamentos, representan puntos ciegos regulatorios. Los actores malintencionados aprovechan estas lagunas legales y de cumplimiento para producir y comercializar medicamentos no aprobados a una escala sin precedentes, exponiendo a los pacientes a riesgos graves, como la administración de productos ineficaces, contaminados o potencialmente peligrosos.

A esta realidad se suma el aumento en la dispensación y envío de medicamentos compuestos hacia Puerto Rico por parte de farmacias ubicadas fuera de la jurisdicción, comúnmente denominadas farmacias no residentes. Si bien estas entidades pueden estar autorizadas en sus estados de origen, su operación hacia pacientes en Puerto Rico plantea retos particulares de fiscalización, acceso a información regulatoria y capacidad de respuesta ante eventos adversos o incumplimientos. La ausencia histórica de un mecanismo uniforme de registro y supervisión local ha limitado la visibilidad de las autoridades regulatorias sobre el volumen, naturaleza y riesgos asociados a medicamentos compuestos que ingresan a la jurisdicción desde el exterior, especialmente aquellos clasificados como de alto riesgo.

A lo anterior, se añade la limitada disponibilidad de información pública sobre las acciones de fiscalización que realizan las entidades reguladoras para atender esta problemática. Actualmente, no existe un mecanismo sistemático de recopilación y divulgación que permita conocer, entre otros aspectos, el número de farmacias no residentes que preparan o dispensan medicamentos compuestos para pacientes localizados en Puerto Rico, las inspecciones efectuadas, la naturaleza de las violaciones detectadas, las investigaciones iniciadas ni las medidas correctivas o disciplinarias impuestas. Esta insuficiencia de datos dificulta la evaluación objetiva de la efectividad del marco regulatorio vigente y limita la capacidad del Estado para asignar recursos y diseñar estrategias basadas en evidencia que fortalezcan la protección de los pacientes.

~~La falta de transparencia sobre las acciones que los reguladores están tomando para abordar este problema agrava la situación. Actualmente, tanto los legisladores como el público general carecen de información clara y detallada sobre las medidas adoptadas por SARAFS y la Junta Examinadora de Farmacia para garantizar que la preparación de medicamentos se realice de manera segura y legal. Esta opacidad dificulta la evaluación de la efectividad de las políticas existentes y la identificación de las áreas donde se necesitan recursos adicionales o reformas regulatorias. Por ejemplo, no se conoce con precisión el número de inspecciones realizadas a instalaciones que manejan medicamentos preparados, ni la naturaleza de las violaciones detectadas, ni las acciones disciplinarias tomadas contra los infractores. Esta falta de datos también limita la~~

capacidad de los responsables de crear políticas para diseñar estrategias que protejan eficazmente a los pacientes.

Además, el aumento en la comercialización de medicamentos preparados a través de prácticas engañosas, como la publicidad indebida en plataformas de telemedicina o telesalud, añade otra capa de complejidad al problema. Estas prácticas no solo confunden a los consumidores, sino que también socavan la confianza en el sistema de salud y en los profesionales que operan dentro de los marcos regulatorios establecidos. La ausencia de una coordinación efectiva entre las juntas reguladoras y otras agencias estatales, contribuye a la persistencia de estas actividades ilícitas.

Esta Ley busca abordar estas deficiencias al establecer un mecanismo robusto de rendición de cuentas y transparencia. Mediante la exigencia de informes bianuales, se proporcionará a los legisladores, reguladores y al público una visión clara de las actividades de supervisión relacionadas con la preparación de medicamentos. Estos informes incluirán datos críticos sobre licencias emitidas, inspecciones realizadas, investigaciones abiertas, acciones disciplinarias tomadas y riesgos emergentes. Al hacerlo, la Ley no solo promoverá una mayor visibilidad sobre las acciones regulatorias, sino que también permitirá identificar las necesidades de recursos humanos y materiales de las juntas reguladoras, garantizando que estén adecuadamente equipadas para enfrentar los desafíos de la preparación de medicamentos de alto riesgo.

Por todo lo cual, resulta imperativo enmendar la “Ley de Farmacia de Puerto Rico” para establecer un marco legal abarcador que regule y supervise específicamente los medicamentos compuestos de alto riesgo, independientemente del entorno en que se administren. Una legislación integral debe definir con claridad estos medicamentos, imponer requisitos de receta individualizada, asegurar la trazabilidad de los ingredientes activos, exigir notificación de eventos adversos y facultar a las autoridades sanitarias para fiscalizar su preparación y dispensación. Solo mediante un régimen normativo coherente y robusto podrá el Estado cumplir con su deber indelegable de proteger la salud pública, garantizar la seguridad del paciente y prevenir que

prácticas comerciales emergentes comprometan estándares básicos de calidad y responsabilidad sanitaria.

Ante este escenario, esta Ley enmienda la “Ley de Farmacias de Puerto Rico” para establecer un marco robusto de transparencia, registro y rendición de cuentas en la supervisión de la preparación y dispensación de medicamentos compuestos, particularmente aquellos clasificados como de alto riesgo. Como componente esencial, se dispone el requisito de registro de farmacias no residentes que envíen, dispensen o distribuyan medicamentos compuestos a pacientes en Puerto Rico, con el propósito de permitir a las autoridades regulatorias identificar, evaluar y supervisar de manera más efectiva estas operaciones extraterritoriales con impacto directo en la salud pública local. Dicho registro facilitará el acceso a información sobre licencias vigentes, historial disciplinario, cumplimiento con estándares federales aplicables y volumen de operaciones hacia la jurisdicción, fortaleciendo la capacidad de vigilancia y respuesta regulatoria.

Mediante la implementación de requisitos de informes periódicos, se proveerá a la Asamblea Legislativa, a las entidades reguladoras y al público información clara y estandarizada sobre las actividades de licenciamiento, registro, inspección, investigación y disciplina relacionadas con establecimientos no residentes que manejen medicamentos compuestos. Estos informes permitirán identificar tendencias, riesgos emergentes y necesidades de recursos humanos y materiales, fortaleciendo la capacidad institucional de fiscalización.

En última instancia, esta legislación tiene como objetivo fortalecer la protección de los pacientes puertorriqueños, asegurando que los medicamentos que reciben sean seguros, efectivos y elaborados bajo estrictos estándares de calidad. Al ~~fomentar~~ promover una supervisión más efectiva, ~~y~~ coordinada y transparente entre la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP), ~~incluyendo supervisión de farmacias no residentes~~ Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud y la Junta Examinadora de Farmacia, esta Ley ~~representa~~ constituye un paso esencial para mitigar ~~crucial hacia la mitigación~~ de los riesgos asociados ~~a con~~ la preparación-n ilegal de medicamentos y la ~~restauración de~~ para preservar la confianza pública en el sistema de salud.

La Asamblea Legislativa reconoce que las farmacias localizadas físicamente en Puerto Rico, debidamente licenciadas, que realizan composición farmacéutica, incluyendo farmacias 503A, ya se encuentran sujetas a licenciamiento, inspección y fiscalización directa bajo la Ley 247-2004, los reglamentos promulgados por el Departamento de Salud, la Junta Examinadora de Farmacia, leyes y reglamentos federales y los estándares USP aplicables. Por tanto, esta Ley no tiene el propósito de duplicar permisos, autorizaciones, reportes ni cargas administrativas sobre dichas farmacias residentes.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 1.02 de la Ley 247-2004, según enmendada,
 2 conocida como “Ley de Farmacia de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

3 “Artículo 1.02. – Propósito.

4 El propósito de esta Ley es promover, preservar y proteger la salud, la
 5 seguridad y el bienestar público mediante el control y reglamentación efectivo de la
 6 práctica de farmacia no residente y el licenciamiento, control y reglamentación de los
 7 establecimientos y personas que manufacturan, distribuyen, dispensan y expenden
 8 medicamentos y artefactos que se utilizan en el diagnóstico, tratamiento y prevención
 9 de enfermedades a pacientes localizados en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
 10 independientemente del lugar físico donde se origine el despacho. Esta Ley no regula o afecta
 11 de modo alguno lo referente al mercadeo de medicamentos por correo desde los
 12 Estados Unidos o el extranjero a la jurisdicción territorial del Estado Libre Asociado
 13 de Puerto Rico.”

14 Artículo 1.- Título

15 Esta Ley se conocerá como la “Ley para la Supervisión sobre Medicamentos
 16 Compuestos de Alto Riesgo”.

1 Sección 2. - Se añaden los nuevos incisos (k-1), (u-1), (u-2), (aa-1), (dd-1) (dd-2) y (nn-
2 1) al Artículo 1.03 de la Ley 247-2004, según enmendada, conocida como “Ley de Farmacia de
3 Puerto Rico”, para que lea como sigue:

4 “Artículo 1.03. — Definiciones.

5 A los fines de esta Ley, los siguientes términos y frases tendrán el significado
6 que a continuación se indica:

7 (a) ...

8 ...

9 (k) ...

10 (k-1) Dispensación a paciente localizado en Puerto Rico – La dispensación o despacho
11 que se realiza por una farmacia no residente a un paciente, prescribiente cuya dirección de
12 entrega se encuentra en Puerto Rico.

13 (l) ...

14 ...

15 (u) ...

16 (u-1) Evento Adverso - Cualquier acontecimiento médico desfavorable que ocurra
17 durante o después del uso de un medicamento y respecto del cual exista una sospecha razonable
18 de asociación con dicho medicamento, independientemente de que dicha relación causal haya
19 sido confirmada.

20 (u-2) Evento Adverso Grave - Un evento adverso que resulte en cualquiera de los
21 siguientes resultados: muerte, una experiencia que ponga en peligro la vida, hospitalización de
22 un paciente; una incapacidad o discapacidad persistente o significativa, una anomalía

1 congénita o defecto de nacimiento, o un evento que requiera, según el juicio médico razonable,
2 una intervención médica o quirúrgica para prevenir alguno de los resultados antes descritos.

3 (v) ...

4 (aa) ...

5 (aa-1) Farmacia no residente – Establecimiento de servicio de salud dedicados a la
6 prestación de servicios farmacéuticos, que incluye: la dispensación de medicamentos de receta,
7 medicamentos sin receta, artefactos y otros productos relacionados con la salud, la prestación
8 de cuidado farmacéutico y otros servicios dentro de las funciones del farmacéutico establecidas
9 en esta Ley, incluyendo a instalaciones 503A, localizadas fuera de Puerto Rico que ejerza
10 dispensación a paciente localizado en Puerto Rico por correo, mensajería, telemedicina o
11 cualquier otro método remoto.

12 (bb) ...

13 ...

14 (dd) ...

15 (dd-1) Ingrediente farmacéutico activo - Toda sustancia destinada a incorporarse en un
16 medicamento terminado y que tenga por objeto proporcionar actividad farmacológica u otro
17 efecto directo en el diagnóstico, cura, mitigación, tratamiento o prevención de enfermedades, o
18 afectar la estructura o cualquier función del organismo humano. El término no incluirá los
19 intermediarios utilizados en la síntesis de dicha sustancia ni los ingredientes inactivos del
20 medicamento, tales como agentes saborizantes o excipientes.

21 (dd-2) Facilidad que fabrica un ingrediente farmacéutico activo - el establecimiento
22 donde se creó originalmente un ingrediente farmacéutico activo mediante procedimientos o

1 manipulaciones químicas, físicas, biológicas o de otro tipo. No incluye a las droguerías ni los
 2 distribuidores al por mayor de medicamentos.

3 (ee) ...

4 ...

5 (nn) ...

6 (nn-1) Medicamento compuesto de alto riesgo –Medicamento compuesto que, según el
 7 reglamento adoptado por el Departamento de Salud con participación de la Junta Examinadora
 8 de Farmacia y oportunidad de comentario público, presente riesgo significativo documentado
 9 por razón de esterilidad, vía de administración, complejidad de preparación, historial de eventos
 10 adversos, margen terapéutico estrecho o ausencia de controles adecuados de trazabilidad.

11 Ningún medicamento será clasificado como medicamento compuesto de alto riesgo salvo
 12 que exista evidencia científica documentada de un riesgo significativo para la salud pública,
 13 sustentada por informes de la Food and Drug Administration (FDA).

14 No se considerará automáticamente de alto riesgo toda preparación estéril por el solo
 15 hecho de ser estéril. La determinación deberá basarse en criterios técnicos y evidencia
 16 documentada.

17 No se considerará “Medicamento Compuesto de Alto Riesgo” la preparación estéril
 18 realizada dentro de un hospital debidamente licenciado en Puerto Rico, cuando: sea realizada
 19 por una farmacia institucional bajo la supervisión de un farmacéutico licenciado; se administre
 20 exclusivamente a un paciente admitido o registrado; y responda a una orden médica válida,
 21 receta o protocolo terapéutico institucional. Esta exclusión aplicará únicamente a hospitales y
 22 no incluirá spas médicos, clínicas de bienestar, prácticas estéticas, clínicas ambulatorias

1 comerciales, consultorios no institucionales ni establecimientos análogos, independientemente
 2 de su licenciamiento.

3 (oo) ...

4 ...

5 (mmm) ...”

6 ~~Artículo 2.- Propósito~~

7 ~~La Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de~~
 8 ~~Salud (SARAFS) y la Junta Examinadora de Farmacia enfrentan un problema sin~~
 9 ~~precedentes, y en aumento, de pacientes que reciben medicamentos preparados~~
 10 ~~ilegalmente, lo que representa riesgos significativos para la salud pública.~~

11 ~~El propósito de esta Ley es entender la naturaleza y escala de las actividades de~~
 12 ~~preparación de medicamentos, incluyendo la supervisión actual de dichas~~
 13 ~~actividades, para informar futuros esfuerzos que aseguren que los reguladores~~
 14 ~~cuenten con los recursos necesarios para proteger a los pacientes.~~

15 Sección 3. - Se añade un nuevo inciso (f) al Artículo 5.04 de la Ley 247-2004, según
 16 enmendada, conocida como “Ley de Farmacia de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

17 “Artículo 5.04. — Medicamentos con requisitos especiales para su
 18 dispensación.

19 (a) ...

20 ...

21 (e) ...

22 (f) Medicamento compuesto de alto riesgo

1 (i) Para la composición y dispensación de medicamentos compuestos de alto
2 riesgo, las farmacias no residentes deberán solicitar y obtener del Secretario una
3 autorización especial para la dispensación de tales medicamentos conforme a los
4 requisitos que se establezcan mediante reglamento. Ninguna farmacia no
5 residente, podrá dispensar medicamentos compuestos de alto riesgo sin contar
6 con dicha autorización especial vigente.

7 (ii) Toda farmacia no residente que obtenga la autorización del Secretario para
8 la dispensación de medicamentos compuestos de alto riesgo, al momento de su
9 solicitud inicial y en cada renovación, deberá presentar ante el Secretario, o la
10 secretaría, división o junta que este designe, una declaración de divulgación de
11 la actividad de composición farmacéutica ("compounding") de medicamentos
12 compuestos preparados y dispensados por dicha farmacia no residente a
13 pacientes localizados en Puerto Rico que debe al menos incluir:

14 1. Las categorías de medicamentos compuestos preparados, incluyendo
15 si son estériles o no estériles;

16 2. La cantidad total de unidades de medicamentos compuestos
17 preparadas durante el período de licencia anterior, clasificadas en
18 preparaciones estériles y no estériles;

19 3. Una descripción de si los medicamentos compuestos se dispensan para
20 administración en la farmacia, en un consultorio médico, dispensación
21 directa al paciente o distribución a otras facilidades;

1 4. El número de pacientes atendidos con medicamentos compuestos
2 durante el período del informe; y

3 5. Cualquier información adicional que la normativa exija
4 razonablemente para evaluar la escala y el perfil de riesgo de las
5 actividades de preparación de medicamentos compuestos.

6 6. Toda farmacia no residente deberá incluir en su declaración de
7 divulgación de la actividad de composición farmacéutica
8 ("compounding") de medicamentos compuestos preparados y
9 dispensados a pacientes localizados en Puerto Rico:

10 a) Una copia del informe más reciente de inspección del estado
11 donde está físicamente operando; y

12 b) Una descripción de cualquier acción disciplinaria impuesta
13 por cualquier organismo regulador en contra de dicha farmacia
14 no residente.

15 (iii) Independientemente de la obtención de una autorización especial para la
16 dispensación de medicamentos compuestos de alto riesgo, se prohíbe:

17 1. El envío directo a spas médicos, clínicas estéticas, centros de bienestar
18 o establecimientos no institucionales no autorizados por la Secretaría
19 Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP) del
20 Departamento de Salud de Puerto Rico;

21 2. La dispensación basada en protocolos estandarizados sin evaluación
22 clínica individualizada;

1 (iv) Todo medicamento compuesto de alto riesgo deberá entregarse acompañado
2 de:

3 1. nombre y dirección de la farmacia preparadora;

4 2. nombre del farmacéutico responsable;

5 3. número de lote o identificación de preparación;

6 4. fecha de preparación y fecha de expiración clínica;

7 5. advertencia visible indicando que el producto es un medicamento
8 compuesto no aprobado por la Food and Drug Administration (FDA),

9 6. Información de contacto para reportar eventos adversos; y

10 7. Rotulación adecuada en cumplimiento con el Artículo 5.02 (d) de esta
11 Ley.

12 (v) Las farmacias no residentes solo podrán vender, transferir o distribuir
13 medicamentos compuestos de alto riesgo si se cumplen los siguientes requisitos:

14 1. El ingrediente farmacéutico activo cumple con la Sección
15 503A(b)(1)(A) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y
16 Cosméticos (21 U.S.C. § 353a(b)(1)(A));

17 2. El ingrediente farmacéutico activo es un producto de grado
18 farmacéutico para uso humano;

19 3. El ingrediente farmacéutico activo está acompañada de una
20 certificación válida que contenga la identidad, pureza y potencia del
21 ingrediente farmacéutico activo, así como cualquier información
22 adicional que requiera el Secretario;

1 4. Todo ingrediente farmacéutico activo que no esté descrito en la
2 Farmacopea de los Estados Unidos (United States Pharmacopeia) o del
3 Formulario Nacional (National Formulary):

4 a. estará acompañado de documentación de pruebas adecuadas de
5 control de calidad realizadas por la facilidad que fabrica un
6 ingrediente farmacéutico activo, un fabricante subsiguiente o un
7 distribuidor al por mayor, que:

8 i. confirmen la identidad y el contenido del ingrediente
9 farmacéutico activo;

10 ii. informen, identifiquen, caractericen y cuantifiquen
11 cada impureza y solvente residual presente en el
12 ingrediente farmacéutico activo en una cantidad que
13 exceda una décima de uno por ciento (0.1%); y

14 iii. contengan cualquier información adicional que pueda
15 requerir el Secretario; o

16 b. antes de utilizar el ingrediente farmacéutico activo en la
17 preparación del medicamento compuesto de alto riesgo, la
18 persona dedicada a la preparación deberá obtener pruebas
19 adecuadas de control de calidad que contengan la información
20 especificada en el Artículo 5.04(f)(vi)(4)(a)(i)-(iii). La
21 información de control de calidad requerida por este Artículo

5.04(f)(vi)(5) podrá incluirse en la certificación descrita en el
Artículo 5.04(f)(vi)(3).

(vii)(a) Toda farmacia no residente deberá mantener documentación verificable
de que el ingrediente farmacéutico activo fue fabricado en una facilidad que
fabrica un ingrediente farmacéutico activo que:

1. está debidamente registrado ante la Food and Drug Administration
(FDA) bajo la Sección 510 del Food, Drug and Cosmetic Act (21 U.S.C.
360);

2. ha sido sometido a una inspección por parte de la Food and Drug
Administration (FDA) como establecimiento de medicamentos para uso
humano;

3. no está actualmente sujeto a una inspección no resuelta por parte de
la Food and Drug Administration (FDA) que fue clasificada como
“Acción Oficial Indicada” (“Official Action Indicated”);

4. Actualmente no está sujeto a ninguna Alerta de Importación emitida
por la Food and Drug Administration (FDA); y

5. no está actualmente sujeto a una Carta de Advertencia no resuelta de
la Food and Drug Administration (FDA).

La documentación requerida por este párrafo también debe incluir: País de
origen, dirección y número de identificación de establecimiento de la Food and
Drug Administration (FDA) de la Facilidad que fabrica un ingrediente
farmacéutico activo.

1 (b) Es ilegal que cualquier fabricante o mayorista venda, transfiera o distribuya
2 un ingrediente farmacéutico activo para su uso en la preparación de compuestos
3 sin proporcionar al comprador la certificación requerida en el Artículo
4 5.04(f)(vi)(3), la documentación de pruebas de control de calidad y la
5 verificación escrita descrita en el Artículo 5.04(f)(vi)(3) al Artículo
6 5.04(f)(vi)(4) y el Artículo 5.04(f)(viii)(a).

7 (viii) La preparación de medicamentos compuestos de alto riesgo deberá cumplir
8 con el Federal Food, Drug and Cosmetic Act, incluyendo las disposiciones de la
9 Sección 503A (21 U.S.C. 353a).

10 (ix) (a) Las farmacias no residentes que se dedican a la venta, transferencia o
11 distribución de medicamentos compuestos de alto riesgo deberán mantener todos
12 los registros relacionados con la adquisición, el examen y la prueba del
13 ingrediente farmacéutico activo durante no menos de dos (2) años después de la
14 fecha de vencimiento del último lote de medicamento compuesto de alto riesgo
15 que contenga el ingrediente farmacéutico activo y, a solicitud del Secretario,
16 deberán proporcionar dichos registros dentro de un tiempo razonable según lo
17 determine el Secretario en función de las circunstancias de la solicitud.

18 (b) El Secretario o la secretaría, división o junta que este designe, tendrá la
19 facultad de requerir a cualquier farmacia no residente que venda, transfiera o
20 distribuya medicamentos compuestos de alto riesgo, así como cualquier
21 Facilidad que fabrique un ingrediente farmacéutico activo, fabricante posterior
22 o Distribuidor al por mayor de medicamentos que venda, transfiera o distribuya

1 un ingrediente farmacéutico activo para su uso en la preparación de compuestos,
2 la documentación, certificaciones, autorizaciones o licencias necesarias para
3 verificar el cumplimiento con los requisitos del Artículo 5.04(f)(v) al Artículo
4 5.04(f)(viii). Negarse a proveer documentación requerida por el Secretario o la
5 secretaría, división o junta que este designe para verificar el cumplimiento con
6 los requisitos del Artículo 5.04(f)(v) al Artículo 5.04(f)(viii) constituirá una
7 violación a esta Ley.

8 (c) El Secretario está autorizado a promulgar las reglas que sean necesarias para
9 implementar esta Ley.

10 (x)(a) Las violaciones del Artículo 5.04(f)(vi), 5.04(f)(vii) y 5.04(f)(viii) darán lugar
11 a:

12 1. una multa de mil dólares (\$1,000) por cada dosis del medicamento compuesto
13 de alto riesgo vendida, transferida o distribuida; y
14 2. revocación de la licencia de Distribuidor al por mayor de medicamentos o de
15 Droguería y cualquier otra licencia, certificado, registro o autorización emitida
16 por el Secretario de Salud.

17 (b) Las violaciones del Artículo 5.04(f)(vii)(b) de esta Ley darán lugar a:

18 1. una multa de mil dólares (\$1,000) por cada miligramo del ingrediente
19 farmacéutico activo distribuido ilegalmente; y
20 2. revocación de la licencia de Distribuidor al por mayor de medicamentos o de
21 Droguería.

1 (c) Las violaciones del Artículo 5.04(f)(ix) resultarán en una multa de \$5,000 y
2 darán lugar a la revocación de la licencia correspondiente.

3 (xi) Todo farmacéutico que conozca de un evento adverso asociado a un
4 medicamento compuesto de alto riesgo dispensado o administrado a un paciente
5 localizado en Puerto Rico deberá notificarlo al Departamento de Salud dentro de
6 diez (10) días laborables desde que advenga en conocimiento, en caso de un evento
7 adverso grave, deberá notificarlo al Departamento de Salud dentro de cinco (5) días
8 laborables desde que advenga en conocimiento."

9 **Artículo 3.- Definiciones**

10 ~~(a) Informe bianual: Reporte que debe ser publicado dos veces al año por las~~
11 ~~juntas reguladoras, conteniendo datos sobre la supervisión de la~~
12 ~~preparación de medicamentos, conforme a los requisitos de esta Ley.~~

13 ~~(b) Junta Examinadora de Farmacia: La entidad reguladora establecida bajo la~~
14 ~~Ley Núm. 247-2004 de Puerto Rico encargada de supervisar la práctica de~~
15 ~~la farmacia, incluyendo la preparación, distribución y dispensación de~~
16 ~~medicamentos.~~

17 ~~(c) Medicamentos Compuestos: La práctica de combinar, mezclar o alterar~~
18 ~~ingredientes para crear un medicamento adaptado a las necesidades de un~~
19 ~~paciente, realizada por farmacias, instalaciones de subcontratación o~~
20 ~~profesionales autorizados, conforme a las regulaciones aplicables.~~

21 ~~(d) Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de~~
22 ~~Salud (SARAFS): Dependencia del Departamento de Salud de Puerto Rico~~

1 ~~encargada de inspeccionar y licenciar facilidades de salud para garantizar~~
2 ~~que cumplan con las leyes y estándares de calidad. Reglamenta y supervisa~~
3 ~~hospitales, farmacias, centros de cirugía ambulatoria y otros servicios de~~
4 ~~salud en la isla.~~

5 ~~(e) Spa médico o clínica de bienestar: Establecimiento que ofrece servicios~~
6 ~~médicos o de bienestar, incluyendo la administración o dispensación de~~
7 ~~medicamentos preparados, pero que no está licenciado como hospital o~~
8 ~~centro quirúrgico ambulatorio.~~

9 Sección 4.- Se añade un nuevo Artículo 5.11-A a la Ley 247-2004, según enmendada,
10 conocida como “Ley de Farmacia de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

11 “Artículo 5.11. — Farmacia.

12 (a)...

13 ...

14 (i) ...

15 Artículo 5.11-A. – Farmacia no residente con dispensación a paciente localizado en
16 Puerto Rico.

17 (a) Ninguna farmacia no residente podrá dispensar, enviar, entregar, causar la entrega,
18 facturar o de cualquier forma proveer medicamentos a pacientes localizados en Puerto Rico sin
19 previamente registrarse ante la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública
20 (SARSP) del Departamento de Salud de Puerto Rico como farmacia no residente y recibir un
21 certificado de registro de farmacia no residente.

1 **(b) Para configurar un registro válido y obtener un certificado de registro de farmacia**
2 **no residente la farmacia no residente deberá presentar:**

3 **1. Una licencia vigente y en buen estado en la jurisdicción donde ubique**
4 **físicamente;**

5 **2. Aprobación del National Association of Boards of Pharmacy Digital**
6 **Pharmacy Accreditation Program;**

7 **3. Identificar un representante de cumplimiento regulatorio para pacientes**
8 **localizados en Puerto Rico, quien fungirá como punto de contacto principal ante**
9 **el Departamento de Salud y responderá ante cualquier evento de**
10 **incumplimiento con esta Ley. Un representante no podrá ser designado**
11 **responsable para más de una farmacia no residente.**

12 **4. Designar un agente representante en Puerto Rico autorizado a recibir**
13 **notificaciones administrativas y judiciales;**

14 **5. Presentar una declaración jurada certificando y haciendo constar que una vez**
15 **registrada la farmacia no residente cumplirá con:**

16 **(i) someter certificaciones de cumplimiento con estándares aplicables de**
17 **preparación y manejo de medicamentos;**

18 **(ii) Mantener y proveer, a requerimiento del Departamento de Salud de**
19 **Puerto Rico documentación verificable relacionada con recetas,**
20 **preparación, dispensación y envío de medicamentos a pacientes**
21 **localizados en Puerto Rico;**

1 (iii) Notificar al Departamento de Salud de Puerto Rico cualquier evento
2 adverso con medicamentos dispensados o administrados a pacientes
3 localizados en Puerto Rico dentro de un término no mayor de diez (10)
4 días laborables o en casos de evento adverso grave en cinco (5) días
5 laborables contados en ambas instancias desde que advenga en
6 conocimiento o razonablemente debió haber conocido de dicho evento.
7 (iv) Cumplir con los requisitos de reporte establecidos en esta Ley.

8 6. Sufragar los derechos establecidos en el Artículo 5.16 de esta Ley.

9 (c) Requisitos de Reporte. Toda farmacia no residente registrada ante la Secretaría
10 Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP) del Departamento de Salud de Puerto
11 Rico, que a su vez haya obtenido la autorización de medicamentos compuestos de alto riesgo,
12 deberá al momento del registro y renovación presentar una declaración de divulgación de la
13 actividad de composición farmacéutica ("compounding") de medicamentos compuestos
14 preparados y dispensados a pacientes localizados en Puerto Rico de conformidad con el Artículo
15 5.04(f) de esta Ley.

16 (d) Al cumplir con los parámetros de este Artículo, la Secretaría Auxiliar para la
17 Regulación de la Salud Pública (SARSP) emitirá un Certificado de Registro de farmacia no
18 residente. El Certificado de Registro de farmacia no residente será válido por un (1) año. El
19 mismo debe ser renovado anualmente mediante presentación de los documentos requeridos en
20 este Artículo al menos cuarenta y cinco (45) días antes de su vencimiento.

21 (e) Ningún plan médico, aseguradora, administrador de beneficios de farmacia (PBM),
22 hospital, clínica, farmacia o proveedor de salud establecido en Puerto Rico y regulado por las

1 leyes y reglamentos del Gobierno de Puerto Rico podrá pagar, procesar, adjudicar o reembolsar
2 reclamaciones por medicamentos dispensados a pacientes localizados en Puerto Rico por
3 farmacias no residentes no registradas conforme a esta Ley.

4 (f) Ningún profesional de la salud autorizado a ejercer en Puerto Rico y sujeto a las
5 leyes y reglamentos del Gobierno de Puerto Rico podrá ordenar, coordinar la dispensación ni
6 administrar medicamentos a través de una farmacia no residente no registrada.

7 (g) El Secretario, en coordinación o por vía de la Secretaría Auxiliar para la Regulación
8 de la Salud Pública (SARSP), está facultado para:

9 1. Emitir órdenes administrativas de cese y desista respecto a la dispensación de
10 medicamentos hacia pacientes localizados en Puerto Rico;

11 2. notificar a agencias regulatorias estatales o federales;

12 3. requerir a planes médicos o PBMs la denegación de reclamaciones
13 provenientes de farmacias no residente son registradas; y

14 4. establecer multas administrativas conforme a la Ley 38-2017, según
15 enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme
16 del Gobierno de Puerto Rico”.

17 (h) El Secretario, en coordinación o por vía de la Secretaría Auxiliar para la Regulación
18 de la Salud Pública (SARSP), deberá:

19 1. Aprobar los reglamentos que sean necesarios para hacer cumplir lo dispuesto
20 en este Artículo.

21 2. Publicar el registro de farmacias no residentes.

1 (i) Nada en este Artículo autoriza a la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la
2 Salud Pública (SARSP) ni al Departamento de Salud de Puerto Rico a regular las operaciones
3 internas de farmacias no residentes. La autoridad conferida se limita exclusivamente a la
4 protección de la salud pública respecto a la dispensación y administración de medicamentos a
5 pacientes localizados en Puerto Rico.

6 (j) Este Artículo se interpretará como una medida de salud pública dirigida
7 exclusivamente a regular la dispensación de medicamentos a pacientes localizados en Puerto
8 Rico y no como una regulación extraterritorial del ejercicio de la profesión de la farmacia fuera
9 de Puerto Rico.”

10 Sección 5.- Se enmienda el Artículo 5.16 de la Ley 247-2004, según enmendada,
11 conocida como “Ley de Farmacia de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

12 “Artículo 5.16. – Vigencia y derechos de licencias, certificados, registros y
13 autorizaciones.

14 (a) Las licencias y registros requeridas en este Capítulo, salvo lo relacionado al
15 Registro de Medicamentos y al Certificado de Registro de Farmacia No Residente, tendrán
16 dos (2) años de vigencia desde la fecha de su expedición y se renovarán en forma
17 escalonada, previo el cumplimiento de los requisitos y procedimientos que se
18 establezcan por reglamento y el pago de los correspondientes derechos; con excepción
19 de los certificados de registros de medicamentos y/o productos biológicos para
20 oficinas médicas, dentales y podiátricas, y para ensayos clínicos en instituciones de
21 educación superior u oficinas médicas, que tendrán tres (3) años de vigencia, y se
22 obtendrán mediante radicación del registro según la fecha de renovación de licencia

1 profesional del médico, dentista o podiatra, cuando corresponda. Además, será deber
2 del Departamento de Salud, en lo posible y mientras los recursos fiscales lo permitan,
3 el establecer los procedimientos para poder radicar y expedir mediante su página
4 electrónica gubernamental (Internet) la solicitud para obtener las licencias requeridas
5 en este Capítulo o el Certificado de Registro Trienal de Medicamentos y/o Productos
6 Biológicos en Oficina Médica, y Certificado de Registro Trienal de Medicamentos y/o
7 Biológicos para Ensayos Clínicos en Institución de Educación Superior y el certificado
8 de registro de farmacia no residente.

9 (b) ...

10 (c) Toda persona que opere más de un establecimiento de los definidos en esta
11 Ley, deberá solicitar y obtener una licencia, certificado, registro o autorización
12 separada para cada uno de los establecimientos.

13 (d) Las licencias, certificados, registros y autorizaciones no serán transferibles.

14 (e) La licencia, certificado, registro o autorización se expedirá a nombre del
15 dueño o razón comercial que la solicite y aplicará solamente al establecimiento en la
16 localización que se indique en la faz de la misma. Además, especificará el tipo de
17 establecimiento para el cual se otorga según definidos en esta Ley.

18 (f) Las licencias, certificados, registros y autorizaciones que se enumeran a
19 continuación pagarán los siguientes derechos que estarán vigentes desde la fecha de
20 aprobación de esta Ley hasta que el Secretario, mediante reglamento, establezca otros
21 derechos:

22 1. ...

1 ...

2 17...

3 18. Certificado de Registro de farmacia no residente - \$500.

4 (g) ...

5 (h) Los ingresos que se recauden por estos conceptos serán depositados en el
 6 Fondo de Salud creado bajo las disposiciones del Artículo 11-A de la Ley Núm. 26 de
 7 13 de noviembre de 1975, según enmendada, para uso exclusivo de la División de
 8 Farmacia, en la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones en el Capítulo V
 9 de esta Ley; con excepción de los fondos que se recauden del Certificado de Registro de
 10 Farmacia no residente. Los recaudos del Certificado de Registro de Farmacia no residente
 11 deberán ser transferidos al Departamento de Salud para fortalecer las capacidades de la
 12 Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP)."

13 Sección 6 Artículo 4.- Se añade un nuevo Artículo 5.18 a la Ley 247-2004, según
 14 enmendada, conocida como "Ley de Farmacia de Puerto Rico", para que lea como sigue:

15 Artículo 5.18. – Informe sobre Supervisión de la Preparación de Medicamentos
 16 Compuestos.

17 La Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP)
 18 Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS), junto con la Oficina
 19 de Planificación y Desarrollo, o cualquier otra secretaría, unidad, oficina o dependencia que el
 20 Secretario del Departamento de Salud determine, Junta Examinadora de Farmacia y el
 21 Departamento de Justicia, desarrollará y publicará un informe bianual sobre la

1 supervisión de la preparación de medicamentos y los riesgos compuestos asociados
2 con dichas prácticas. Dicho informe incluirá los siguientes elementos:

3 (a) El número de certificaciones a farmacias no residentes y tipo de licencias
4 emitidas por el Secretario, o la secretaria, división o junta que este designe, la
5 ~~Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de~~
6 ~~Salud (SARAFS) y la Junta Examinadora de Farmacia según aplique, bajo las~~
7 ~~cuales el titular de la licencia pueda realizar la preparación para la dispensación~~
8 de medicamentos compuestos de alto riesgo, incluyendo ~~un desglose de licencias~~
9 ~~residentes y no residentes, y licencias~~ autorizaciones para la dispensación
10 ~~preparación de medicamentos estéril compuestos estériles para uso parenteral o~~
11 cualesquiera otros medicamentos que requieran técnicas asépticas especiales.

12 (b) El número de certificados de registro de farmacias no residentes emitidos por la
13 Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP).

14 ~~(b)~~ (c) El número de instalaciones y prácticas licenciadas, autorizadas o registradas
15 que han sido inspeccionadas en el último año y en los últimos tres años,
16 desglosado por tipo de licencia, autorización o registro.

17 ~~(e)~~ (d) El número de inspecciones realizadas a instalaciones y prácticas
18 involucradas en la preparación de medicamentos compuestos de alto riesgo, o en
19 el manejo, almacenamiento, administración, dispensación, distribución u otro
20 uso de medicamentos preparados en el ámbito minorista o ambulatorio,
21 incluyendo farmacias no residentes 503A, ~~instalaciones de subcontratación~~ 503B

1 ~~y spas médicos~~, pero excluyendo instalaciones de salud licenciadas como
 2 hospitales o centros quirúrgicos ambulatorios.

3 ~~(d)~~ (e) Una descripción de la naturaleza y gravedad de cualquier deficiencia o
 4 posible violación observada durante las inspecciones o reportadas por
 5 farmacéuticos.

6 ~~(e)~~ (f) El número de investigaciones abiertas por ~~cada entidad reguladora~~, el
 7 Departamento de Salud, o cualquier otra agencia estatal a la que se le haya referido
 8 una investigación, relacionadas con la preparación de medicamentos.

9 ~~(f)~~ (g) El número y tipo de acciones disciplinarias tomadas por el Departamento
 10 de Salud~~cada entidad reguladora~~, o cualquier otra agencia estatal a la que se le
 11 haya referido una investigación, relacionadas con la preparación de medicamentos
 12 compuestos.

13 ~~(g)~~ El número y tipo de acciones disciplinarias tomadas por cada entidad
 14 reguladora, o cualquier otra agencia estatal, relacionadas con la
 15 comercialización, publicidad o promoción engañosa o indebida de
 16 medicamentos compuestos, servicios de telemedicina o servicios de telesalud.

17 (h) Una evaluación de los recursos humanos y materiales de la ~~Junta de~~
 18 ~~Farmacia, así como de~~ Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública
 19 (SARSP) Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud, en relación
 20 con la escala estimada de la preparación de medicamentos compuestos de alto
 21 riesgo.

(i) Un análisis de la naturaleza y gravedad de los riesgos emergentes relacionados con la preparación de medicamentos compuestos *de alto riesgo*, y la distribución, comercialización y venta de medicamentos compuestos.

El primer informe se publicará a más tardar el ~~1~~ 30 de septiembre de 2027 ~~2026~~, con datos correspondientes del 1 de enero de 2027 ~~2026~~ al 30 de junio de 2027 ~~2026~~. Posteriormente, los informes se publicarán dos veces al año, a más tardar el 1 de marzo y el 1 de septiembre de cada año, conteniendo datos de los seis meses anteriores, respectivamente. Los informes no contendrán información protegida por la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA).

~~Artículo 5. Deber de Coordinación.~~

~~La Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS) lidera la coordinación con la Junta Examinadora de Farmacia, el Departamento de Justicia, para garantizar la recopilación precisa y oportuna de los datos requeridos para los informes bianuales. La Junta Examinadora de Farmacia proporcionará la información relevante dentro de sus jurisdicciones en un plazo no mayor a 30 días naturales tras la solicitud de SARAFS.~~

~~Artículo 6. Acceso Público.~~

Los informes bianuales serán publicados en la página electrónica oficial ~~los sitios web oficiales~~ de la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP) o del Departamento de Salud de Puerto Rico ~~para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS) y de la Junta Examinadora de Farmacia~~, además de estar disponibles para consulta pública sin costo alguno. ~~Las entidades notificarán~~ La

1 Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP) notificará al público
2 sobre la publicación de cada informe mediante comunicados oficiales.

3 ~~Artículo 7.- Prohibición de Costos Adicionales.~~

4 Se prohíbe imponer cualquier cargo monetario a los ciudadanos, profesionales
5 de la salud o instalaciones licenciadas para el cumplimiento ~~de las disposiciones de la~~
6 divulgación del informe bianual establecido en de esta Ley Sección.

7 Sección 7.- Farmacias localizadas físicamente en la jurisdicción de Puerto Rico.

8 Nada de lo dispuesto en estas enmiendas, se interpretará como una limitación,
9 sustitución, duplicación o ampliación de los requisitos aplicables a farmacias localizadas
10 físicamente en la jurisdicción de Puerto Rico, debidamente licenciadas bajo la Ley 247-2004.
11 Estas farmacias, incluyendo las farmacias 503A que realicen composición farmacéutica estéril
12 o no estéril, continuarán reguladas por la “Ley de Farmacia de Puerto Rico”, sus reglamentos,
13 la Junta Examinadora de Farmacia, el Departamento de Salud y los estándares de USP
14 aplicables.

15 Sección 8.- Reglamentación.

16 El Secretario del Departamento de Salud está autorizado y deberá, dentro de ciento
17 ochenta (180) días de aprobada esta Ley, aprobar o enmendar los reglamentos que sean
18 necesarios para el fiel cumplimiento de esta Ley.

19 Sección 9.- ~~Artículo 8-~~ Cláusula de separabilidad.

20 Si alguna de las disposiciones de esta Ley o su aplicación fuere declarada
21 inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectará la
22 ejecutabilidad y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido objeto de

1 dictamen adverso.

2 Sección 10.- ~~Artículo 9.-~~ Vigencia.

3 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.